



Flashcards — Introdução à Enfermagem

60 cartões com os conceitos essenciais • Baseado no Princípio 80/20

🎯 Curso: Enfermagem (EN_430) • 120h

✚ TEORIA

Quais são os 3 níveis da Teoria das Necessidades Básicas de Wanda Horta?

1. **Psicobiológicas** — oxigenação, nutrição, eliminação, sono, locomoção, cuidado corporal
2. **Psicossociais** — comunicação, segurança emocional, interação social, lazer, autoestima
3. **Psicoespirituais** — crenças, religiosidade, transcendência, valores

✚ TEORIA

O que é a SAE e quais suas 5 etapas?

SAE = Sistematização da Assistência de Enfermagem. Processo que organiza o trabalho do enfermeiro.

5 etapas: **H**istórico → **D**iagnóstico → **P**lanejamento → **I**mplementação → **A**valiação

🧠 Mnemônico: **HDPIA** — "Hoje, Diagnóstico, Planejamento, Implementação, Avaliação"

✚ TEORIA

Qual a base legal que regulamenta a SAE no Brasil?

Resolução COFEN 358/2009.

Dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como atividade privativa do enfermeiro, que deve ocorrer em ambientes públicos e privados onde ocorre o cuidado de enfermagem.

💊 MEDICAÇÃO

Quais são os 7 Certos da Administração de Medicamentos?

1. **P**aciente certo
2. **M**edicamento certo
3. **D**ose certa
4. **V**ia certa
5. **H**orário certo
6. **R**egistro certo
7. **O**rientação certa

🧠 Mnemônico: **PMDVHRO** — Paciente, Medicamento, Dose, Via, Horário, Registro, Orientação

 MEDICAÇÃO**Quais são as vias enterais de administração de medicamentos?**

Vias Enterais — utilizam o trato gastrointestinal:

- ✓ **Oral (VO)** — comprimidos, cápsulas, líquidos
- ✓ **Sublingual (SL)** — absorção rápida, bypass hepático
- ✓ **Sonda Nasogástrica (SNG)** — para pacientes impossibilitados de deglutir
- ✓ **Sonda Nasoenteral (SNE)** — dieta/medicação diretamente no intestino

 MEDICAÇÃO**Quais são as 4 vias parenterais? Diferencie ângulo, volume máximo e local.**

ID (intradérmica): 10–15°, 0,5 mL — antebraço (PPD, BCG)

SC (subcutânea): 45–90°, 1–2 mL — abdômen, braço (insulina, heparina)

IM (intramuscular): 90°, 3–5 mL — deltoide (2mL), vasto lateral (5mL), glúteo (4mL)

EV (endovenosa): 25–45°, volume variável — veias superficiais

 "15, 45, 90: quanto + fundo, maior o ângulo"

 HIGIENE**Qual a diferença entre assepsia e antissepsia?**

Assepsia: Conjunto de medidas para **impedir** a entrada de microrganismos (campo estéril, material esterilizado)

Antissepsia: Aplicação de substâncias para **reduzir** microrganismos na pele/mucosas (álcool 70%, PVPI, clorexidina)

Degermação: Lavagem das mãos com água e sabão

 HIGIENE**Quais são os 5 Momentos da Higienização das Mãos (OMS)?**

1. **Antes** de tocar o paciente
2. **Antes** de procedimento limpo/asséptico
3. **Após** risco de exposição a fluidos corporais
4. **Após** tocar o paciente
5. **Após** tocar superfícies próximas ao paciente

 "Antes do paciente, Antes do procedimento, Após fluido, Após paciente, Após ambiente"

 CURATIVOS

Como as feridas são classificadas?

Quanto à causa: cirúrgica, traumática, ulcerativa

Quanto à contaminação: limpa, limpa-contaminada, contaminada, infectada

Quanto ao tempo: aguda (até 6 semanas) × crônica (>6 semanas)

Quanto à profundidade: superficial, parcial, total

 CURATIVOS

Cite 4 tipos de coberturas especiais e suas indicações.

Hidrocoloide: feridas secas a pouco exsudativas — mantém ambiente úmido

Alginato de cálcio: feridas muito exsudativas — alta absorção

Carvão ativado com prata: feridas infectadas com odor — antimicrobiano

Espuma (poliuretano): feridas moderadamente exsudativas — conforto e absorção

Filme transparente: proteção de pele íntegra, fixação de cateteres

 OXIGÊNIO

Quais são os dispositivos de oxigenoterapia e seus fluxos?

Cateter nasal (CN): 1–5 L/min → FiO₂ 24–40%

Máscara simples: 5–10 L/min → FiO₂ 35–50%

Máscara de Venturi: fluxo exato → FiO₂ controlada 24–50%

Máscara c/ reservatório (não reinalante): 10–15 L/min → FiO₂ 60–95%

 CATETERISMOS

Qual a diferença entre SNG, SNE, Sonda Vesical e Sonda Retal?

SNG (Sonda Nasogástrica): descompressão gástrica, lavagem, coleta de conteúdo — nariz → estômago

SNE (Sonda Nasoenteral): administração de dieta/medicação — nariz → intestino

Sonda Vesical (alívio/demora): esvaziamento vesical, diurese — uretra → bexiga

Sonda Retal: eliminação de gases, fecaloma — ânus → reto

 TERMINOLOGIAS

O que significam: afebril, normocárdico, eupneúco, normotenso?

Afebril: sem febre (temperatura normal: 36–37°C)

Normocárdico: frequência cardíaca normal (60–100 bpm)

Eupneico: respiração normal (16–20 irpm)

Normotenso: pressão arterial normal (~120/80 mmHg)

Bônus: Anictérico (sem icterícia), Normocorado (coloração normal), Lúcido e Orientado (consciente)

 TERMINOLOGIAS

O que significam: anictérico, normocorado, hidratado, lúcido e orientado?

Anictérico: sem coloração amarelada na pele/escleróticas (sem icterícia)

Normocorado: coloração normal da pele e mucosas (corado)

Hidratado: turgor e elasticidade da pele preservados

Lúcido e Orientado (L+O): consciente, responde a comandos, orientado no tempo e espaço

POSIÇÕES

Cite 4 posições da cama hospitalar e suas indicações.

Fowler (45°): paciente sentado — dispneia, alimentação, aspiração

Semi-Fowler (30°): conforto, repouso, prevenção de broncoaspiração

Sims (decúbito lateral): administração de SNE, clister, exames retais

Trendelenburg: inclinada com cabeça baixa — choque, hipotensão, escoamento brônquico

MEDIDAS

Como classificar o IMC? Quais os pontos de corte?

IMC = Peso (kg) / Altura² (m)

< 18,5: Magreza (abaixo do peso)

18,5 – 24,9: Peso normal (eutrófico)

25,0 – 29,9: Sobrepeso

30,0 – 34,9: Obesidade grau I

35,0 – 39,9: Obesidade grau II

≥ 40: Obesidade grau III (mórbida)

TERAPIAS

Quando indicar crioterapia e quando indicar termoterapia?

Crioterapia (frio) ❄️: 20 min — edema agudo, trauma, processo inflamatório inicial, dor aguda, hemorragia, pós-operatório imediato

Termoterapia (calor) 🔥: 20 min — contraturas musculares, abscesso, dor crônica, processo inflamatório crônico, hematomas

CONTENÇÃO

Quais os tipos de contenção e os cuidados de enfermagem?

Tipos:

- **Mecânica:** faixas (punho, tórax, joelhos, cadeira)
- **Química:** sedação medicamentosa
- **Ambiental:** grades elevadas, cama baixa, supervisão

Cuidados: avaliar circulação a cada 1h, liberar a cada 2h, documentar, prescrição médica necessária

PÓS-MORTE

Quais os passos do processo pós-morte (cuidados com o corpo)?

1. Confirmar óbito e registrar
2. Aguardar declaração de óbito (médico)
3. Posicionar corpo em decúbito dorsal
4. Realizar higiene corporal
5. Retirar dispositivos (sondas, cateteres, curativos)
6. Identificar corpo (pulseira, etiqueta)
7. Respeitar crenças religiosas e aspectos éticos
8. Apoiar a família

ADMISSÃO/ALTA

Quais os principais passos na admissão e alta do paciente?

Admissão: identificação + pulseira → sinais vitais → histórico e exame físico → orientações → pertences

Alta: resumo de alta (evolução) → orientações ao paciente/cuidador → receitas e atestados → desocupação do leito → documentação

 EXAMES**Quais os cuidados na coleta de exames: sangue, urina, fezes e escarro?**

Sangue: punção venosa — torniquete, assepsia, agulha adequada, frasco correto, jejum se necessário

Urina: jato médio (urocultura), 24h (dosagem), primeira urina da manhã (EAS)

Fezes: parasitológico (3 amostras), sangue oculto (dieta específica)

Escarro: matinal, jejum, lavagem brônquica, recipiente estéril

 TEORIA**Qual a relação entre a Teoria de Wanda Horta e a hierarquia de Maslow?**

Wanda Horta baseou sua **Teoria das Necessidades Humanas Básicas** na hierarquia de Maslow, adaptando-a para a enfermagem.

Maslow: Fisiológicas → Segurança → Social → Estima → Autorrealização

Horta: Psicobiológicas (equivalem a fisiológicas + segurança) → Psicossociais (social + estima) → Psicoespirituais (autorrealização/transcendência)

 ANOTAÇÃO**Quais os princípios de uma boa anotação de enfermagem?****Princípios:**

- **Objetividade** — informações claras e diretas
- **Cronologia** — ordem dos acontecimentos
- **Clareza** — letra legível, sem rasuras
- **Compleitude** — dados completos (data, hora, assinatura, COREN)
- **Sigilo** — informações confidenciais
- **Precisão** — terminologias técnicas corretas

 MEDICAÇÃO**Quais são os principais locais de aplicação da via intramuscular (IM)?**

Músculo Deltoide: face externa do braço — volume máx. 2 mL

Músculo Vasto Lateral da Coxa: face ântero-lateral da coxa — volume máx. 5 mL

Músculo Glúteo Máximo: quadrante superior externo da nádega — volume máx. 4 mL

Músculo Dorsoglúteo: região glútea profunda — volume máx. 4 mL

 **Cuidado:** região glútea — risco de lesão do nervo ciático!

 HIGIENE**Quais os passos para calçar luvas estéreis (técnica correta)?**

1. Higienizar as mãos
2. Abrir o envelope (tocar apenas na parte externa)
3. Calçar a 1ª luva: pegar pelo avesso do punho (parte interna), com a mão dominante
4. Calçar a 2ª luva: com a mão já enluvada, deslizar os dedos sob o punho dobrado (parte externa)
5. Ajustar os dedos sem tocar na pele
6. Mãos postas à frente, acima da cintura — **não tocar em superfícies não estéreis!**

 CURATIVOS**Qual a diferença entre curativo com técnica limpa e técnica estéril?**

Técnica limpa: uso de material limpo, não necessariamente estéril. Para **feridas limpas, fechadas ou crônicas** sem sinais de infecção.

Técnica estéril: uso de material estéril (luva estéril, gaze estéril, campo estéril). Para **feridas abertas, cirúrgicas, queimaduras ou com risco de infecção**.

 TERMINOLOGIAS**O que significa: diurese presente, eliminações fisiológicas, deambulando?**

Diurese presente/ausente: paciente urinou/não urinou (quantidade e aspecto da urina)

Eliminações fisiológicas preservadas: urina e fezes dentro da normalidade

Deambulando: paciente andando (sem restrições de locomoção)

Em uso de: indicação de dispositivo ou medicação em uso

Intercorrência: evento inesperado durante a assistência

 POSIÇÕES**O que é mudança de decúbito e qual sua finalidade?**

Mudança de decúbito: reposicionamento do paciente no leito a cada **2 horas**.

Finalidade: prevenir lesões por pressão (LPP/escara), aliviar pontos de compressão, melhorar conforto, facilitar higiene, prevenir contraturas e complicações respiratórias.

Posições alternadas: dorsal → lateral D → dorsal → lateral E → dorsal

 CATETERISMOS**Quais os cuidados de enfermagem na sonda vesical de demora?****Cuidados essenciais:**

- Técnica estéril na inserção
- Fixar a sonda na coxa (feminino) / abdômen (masculino)
- Manter saco coletor abaixo do nível da bexiga
- Não desconectar o sistema fechado
- Higiene diária do meato uretral
- Observar características da urina (cor, aspecto, volume)
- Registrar balanço hídrico

 MEDICAÇÃO**Quais os cuidados na administração de medicamentos por sonda?****Cuidados:**

- Verificar posicionamento da sonda antes
- Administrar cada medicação **separadamente**
- Triturar comprimidos duros (não triturar: sublingual, liberação prolongada, drágeas)
- Diluir em água (20–30 mL)
- Lavar sonda com 20 mL de água entre cada medicação
- Lavar sonda antes e após administração
- Manter cabeceira elevada (Fowler)

 ANOTAÇÃO**Qual a estrutura de uma anotação de enfermagem completa?****Estrutura SOAP (ou similar):**

S — Subjetivo: queixas do paciente ("refere dor 8/10")

O — Objetivo: dados observados (sinais vitais, exame físico)

A — Avaliação: análise/impressão clínica

P — Plano: intervenções realizadas e previstas

Sempre: data, hora, assinatura e número do COREN

 TEORIA**O que são necessidades psicobiológicas? Dê 5 exemplos.**

São necessidades relacionadas ao **funcionamento biológico** e à **sobrevivência** do ser humano.

Exemplos:

1. Oxigenação — respiração adequada
2. Nutrição — alimentação e hidratação
3. Eliminação — urinar e evacuar
4. Sono e repouso — descanso adequado
5. Cuidado corporal — higiene e integridade da pele
6. Locomoção — movimentação e atividade física

 TEORIA**O que são necessidades psicossociais e psicoespirituais?**

Psicossociais: relacionadas à vida em sociedade e ao equilíbrio emocional

→ Comunicação, interação social, lazer, segurança emocional, autoestima, amor, aceitação

Psicoespirituais: relacionadas à transcendência e ao sentido da vida

→ Crenças religiosas, valores, espiritualidade, esperança, gratidão, perdão

 HIGIENE**Quais os materiais necessários para o banho no leito?****Materiais:**

- Bacia com água morna
- Sabonete neutro/líquido
- Toalhas de banho (2–3)
- Luvas de procedimento
- Roupas de cama limpa
- Comadre/urinol
- Produtos de higiene (xampu, hidratante)
- Biombo/lençol para privacidade

Sequência: olhos → face → braços → tórax → abdômen → MMII → períneo → dorso

 CONTENÇÃO**Quais as indicações para contenção mecânica de pacientes?****Indicações (último recurso!):**

- Risco de queda (agitação psicomotora, delirium)
- Risco de remoção de dispositivos (TOT, sonda, cateter, dreno)
- Proteção do próprio paciente ou de terceiros
- Procedimentos invasivos emergenciais

Contraindicações: punição, conveniência da equipe, pacientes sedados sem risco

 PÓS-MORTE**Qual o papel do enfermeiro no processo pós-morte?****Atribuições do enfermeiro:**

- Confirmar sinais de morte e registrar no prontuário
- Comunicar o médico para declaração de óbito
- Preparar o corpo: higiene, posicionamento, identificação
- Retirar dispositivos invasivos
- Respeitar aspectos culturais e religiosos
- Comunicar e apoiar a família com sensibilidade
- Encaminhar corpo ao serviço funerário
- Providenciar documentação legal

 EXAMES**O que é balanço hídrico e como é realizado?**

Balanço hídrico: registro de todos os líquidos ingeridos e eliminados pelo paciente em 24h.

Ingestas (Líquidos): água, dieta via SNE, medicamentos EV, soros, sangue

Eliminações (Perdas): diurese, vômito, drenos, fístulas, evacuações líquidas

Cálculo: Balanço = Ingesta total - Perda total

Positivo (+): reteve líquido → risco de edema

Negativo (-): perdeu líquido → risco de desidratação

 MEDICAÇÃO**Como calcular gotejamento de soro (macrogotas e microgotas)?****Fórmulas essenciais:**

Macrogotas/min = Volume (mL) ÷ (Tempo (h) × 3)
ou Volume (mL) ÷ Tempo (min) × 20

Microgotas/min = Volume (mL) ÷ Tempo (h)
ou Macrogotas × 3

Exemplo: SF 0,9% 500 mL em 8h

Macrogotas = $500 \div 24 = \sim 21$ gotas/min

 TERMINOLOGIAS**O que significam as abreviações: CV, FC, PA, FR, Tax, SatO₂?**

CV — Cardiovascular (sistema circulatório)

FC — Frequência Cardíaca (normal: 60–100 bpm)

PA — Pressão Arterial (normal: ~120×80 mmHg)

FR — Frequência Respiratória (normal: 16–20 irpm)

Tax — Temperatura axilar (normal: 36–37°C)

SatO₂ — Saturação de Oxigênio (normal: ≥95%)

 CURATIVOS**Quais os passos para realizar um curativo simples?**

1. Higienizar as mãos e calçar luvas de procedimento
2. Remover curativo anterior (se houver)
3. Avaliar a ferida (tamanho, exsudato, odor, tecido)
4. Limpar a ferida com SF 0,9% (movimento centro → periferia)
5. Secar bordas com gaze estéril
6. Aplicar cobertura indicada
7. Cobrir com gaze e fixar com esparadrapo/atadura
8. Desprezar resíduos e higienizar mãos
9. Registrar: aspecto, cobertura, data e hora

 OXIGÊNIO**Quais os cuidados de enfermagem na oxigenoterapia?****Cuidados:**

- Manter vias aéreas pérvias
- Umidificar O₂ (evitar ressecamento de mucosas)
- Monitorar SatO₂ e sinais de desconforto respiratório
- Verificar fluxo e dispositivo conforme prescrição
- Trocar cateter/máscara a cada 24h
- Manter cabeceira elevada (Fowler)
- Sinalização de risco: "Proibido fumar — Oxigênio em uso"

 HIGIENE**O que são precauções padrão e quais as principais medidas?**

Precauções Padrão: medidas de proteção universal aplicadas a TODOS os pacientes.

Medidas:

- Higienização das mãos
- Uso de EPIs (luvas, máscara, avental, óculos)
- Descarte correto de perfurocortantes
- Manipulação segura de resíduos
- Limpeza e desinfecção de superfícies

 MEDICAÇÃO**Qual a diferença entre ampola, frasco-ampola e frasco (soro)?**

Ampola: vidro fino, dose única — quebrar o gargalo (proteger com algodão)

Frasco-ampola: vidro grosso, tampa de borracha — usar agulha para aspirar (dose única ou múltipla)

Frasco de soro: plástico ou vidro, grande volume — para infusão EV (SF 0,9%, Ringer, glicose)

 MEDIDAS**Quais são as principais medidas antropométricas e como são realizadas?**

Peso: balança calibrada, paciente descalço e com roupas leves

Altura: estadiômetro, paciente em posição ereta, descalço

IMC: $\text{peso} \div \text{altura}^2$ — classificação (magreza, normal, sobrepeso, obesidade)

Circunferência abdominal: fita métrica no ponto médio entre costela e crista ilíaca

Pregas cutâneas: adipômetro — avaliação de percentual de gordura

 CATETERISMOS**Quais as complicações possíveis da SNG e SNE?****SNG:**

- Aspiração pulmonar (posicionamento incorreto)
- Lesão de mucosa nasal/esofágica
- Desconforto, náuseas, epistaxe
- Obstrução da sonda

SNE:

- Deslocamento/obstrução
- Síndrome de realimentação
- Diarreia/constipação
- Broncoaspiração
- Infecção

 ADMISSÃO**O que deve conter no histórico de enfermagem na admissão?****Histórico de Enfermagem (1ª etapa da SAE):**

- Dados de identificação (nome, idade, leito, prontuário)
- Queixa principal (QP) e história da doença atual (HDA)
- História patológica pregressa (HPP)
- Medicações em uso, alergias
- Exame físico: sinais vitais, cabeça/pescoço, tórax, abdômen, MMSS/MMII
- Condições de pele, mucosas, eliminações
- Avaliação psicossocial e espiritual

 TEORIA**Em quais situações a Teoria das Necessidades Básicas se aplica na prática?**

Em **todas** as situações de cuidado de enfermagem! A teoria é a base para:

- Identificar diagnósticos de enfermagem (NANDA-I)
- Planejar intervenções personalizadas
- Avaliar a evolução do paciente
- Garantir cuidado integral e humanizado
- Priorizar ações (necessidades psicobiológicas primeiro → depois psicossociais → psicoespirituais)

 TERMINOLOGIAS**O que significam: bradicárdico, taquicárdico, hipertenso, hipotenso?**

Bradicárdico: FC < 60 bpm (coração lento)

Taquicárdico: FC > 100 bpm (coração acelerado)

Hipertenso: PA > 140×90 mmHg (pressão alta)

Hipotenso: PA < 90×60 mmHg (pressão baixa)

Bradipneico: FR < 16 irpm (respiração lenta)

Taquipneico: FR > 20 irpm (respiração rápida)

 MEDICAÇÃO**Quais os cuidados na administração de medicamentos EV?****Cuidados na via EV:**

- Verificar acesso venoso (sem sinais de flebite/infiltração)
- Realizar flush com SF 0,9% antes e após
- Administrar em push lentamente (exceto se prescrito em bolus)
- Observar sinais de reações adversas
- Respeitar compatibilidade de medicamentos na mesma via
- Trocar equipo conforme protocolo (72h ou 24h para nutrição parenteral/sangue)

 CURATIVOS**O que é lesão por pressão (LPP) e quais os estágios?**

LPP (Escara): lesão na pele/tecido subjacente por pressão prolongada + proeminência óssea.

Estágios (NPUAP):

Estágio 1: pele íntegra, eritema não branqueável

Estágio 2: perda parcial da pele (bolha/fricção)

Estágio 3: perda total da pele (gordura visível)

Estágio 4: perda total + exposição óssea/muscular

Não classificável: totalmente coberta por esfacelo/escara

 HIGIENE**Quais os tipos de EPI e quando utilizar cada um?****EPIs na enfermagem:**

- **Luvas de procedimento:** contato com sangue/fluidos/mucosas
- **Luvas estéreis:** procedimentos cirúrgicos/invasivos, parto
- **Máscara cirúrgica:** proteção de gotículas (tosse, espirro)
- **Máscara N95/PFF2:** aerossóis (tuberculose, COVID-19, intubação)
- **Avental:** risco de respingos/sangue
- **Óculos de proteção:** proteção de mucosa ocular
- **Gorro:** campos estéreis, centro cirúrgico

 CATETERISMOS**Como verificar o posicionamento correto da SNG?****Métodos para verificar posicionamento da SNG:**

✓ **Padrão ouro:** Raio-X de tórax/abdômen

✓ **Métodos à beira do leito:**

1. **Aspirar conteúdo gástrico** (verificar pH: gástrico < 5,5)
2. **Injetar ar (20-30 mL)** + ausculta epigástrica (borborigmo)
3. **Medir a distância externa** da sonda (marcação de referência)

✗ **Não usar:** teste de borbulhamento em copo d'água (risco de aspiração!)

 TERMINOLOGIAS

Traduza: TOT, CVC, dreno de Penrose, dreno de Portovac.

TOT (Tubo Orotraqueal/Traqueal): via aérea artificial inserida pela boca ou traqueostomia

CVC (Cateter Venoso Central): acesso venoso em veia central (subclávia, jugular, femoral)

Dreno de Penrose: látex, drenagem passiva — cavidades/abscessos (gravidade)

Dreno de Portovac/JP: sistema fechado a vácuo — drenagem ativa pós-cirúrgica

 TERAPIAS

Quais as contraindicações da crioterapia e termoterapia?

Crioterapia ❄️:

- Contraindicada em: hipersensibilidade ao frio, crioglobulinemia, doença vascular periférica grave, área com circulação comprometida

Termoterapia 🔥:

- Contraindicada em: área com sangramento ativo, ferida aberta recente, tumor maligno, pacientes inconscientes/sem sensibilidade, edema agudo, processo inflamatório agudo

 MEDICAÇÃO

O que é a regra de três na enfermagem e como aplicar?

Regra de três: método para calcular doses e diluições.

Fórmula: Dose prescrita × Volume total ÷ Dose disponível

Exemplo: Prescrição: Heparina 5.000 UI EV.
Disponível: Frasco de 5.000 UI/5mL
Cálculo: $5.000 \times 5 \div 5.000 = 5 \text{ mL}$

Dica: Monte as proporções: Dose disponível : Volume = Dose prescrita : X

 TEORIA

Qual a importância dos diagnósticos de enfermagem (NANDA-I)?

Diagnóstico de Enfermagem (NANDA-I):

juízo clínico sobre respostas do indivíduo/família/comunidade a processos vitais ou problemas de saúde.

Importância:

- Base para escolha das intervenções (NIC)
- Resultados mensuráveis (NOC)
- Comunicação padronizada entre equipe
- Documentação do raciocínio clínico
- Subsídio para auditoria e pesquisa

Exemplo: "Risco de integridade da pele prejudicada relacionado a imobilidade no leito"

 ADMISSÃO**O que deve ser verificado na passagem de plantão de enfermagem?****Passagem de plantão — checklist mínimo:**

- Número de pacientes e suas condições clínicas
- Intercorrências do turno anterior
- Procedimentos realizados e pendentes
- Medicações administradas e próximos horários
- Pacientes críticos/instáveis
- Dispositivos (sondas, drenos, cateteres, acessos)
- Exames realizados e resultados pendentes
- Prescrições médicas novas/alterações
- Materiais/equipamentos (estoque, falhas)

 POSIÇÕES**Qual a diferença entre cama ocupada e desocupada na arrumação?**

Cama desocupada: leito vazio — troca **completa** de roupa de cama (lençol de baixo, lençol móvel, coberta, fronha, impermeável). Feita na admissão ou após alta.

Cama ocupada: paciente no leito — troca **parcial** (lençol móvel, fronha). Técnica de rolagem do paciente para trocar o lençol inferior. Feita diariamente ou quando necessário.

 MEDICAÇÃO**O que fazer em caso de erro de medicação?****Conduta em erro de medicação:**

1. **Não omitir** — comunicar imediatamente o enfermeiro responsável
2. **Avaliar o paciente** — sinais vitais, reações adversas
3. **Notificar o médico** para conduta
4. **Prestar assistência** necessária ao paciente
5. **Registrar** no prontuário e notificar a farmácia
6. **Preencher** formulário de notificação de incidentes
7. **Analisar a causa** para prevenir recorrência (cultura justa, não punitiva)

 REVISÃO GERAL **TOP 5 CONCEITOS 80/20 — Quais os 20% que geram 80% dos resultados?**

- 🏆 **Teoria das Necessidades Básicas** (fundamento de tudo)
- 🏆 **SAE + Anotação de Enfermagem** (processo de trabalho)
- 🏆 **Administração de Medicamentos** (7 certos + vias)
- 🏆 **Assepsia, Higiene e Segurança** (base de todos os procedimentos)
- 🏆 **Curativos e Feridas** (procedimento clínico essencial)

★ Domine esses 5 tópicos e você terá 80% do conhecimento necessário para a disciplina!



Gabarito — Flashcards de Introdução à Enfermagem

Índice de respostas para consulta rápida

1. Psicobiológicas, Psicossociais, Psicoespirituais
2. SAE: H → D → P → I → A
3. Resolução COFEN 358/2009
4. Paciente, Med., Dose, Via, Horário, Registro, Orientação
5. Oral, Sublingual, SNG, SNE
6. ID/SC/IM/EV — ângulos e volumes
7. Assepsia=impedir × Antissepsia=reduzir
8. 5 momentos da higienização (OMS)
9. Causa, contaminação, tempo, profundidade
10. Hidrocoloide, alginato, carvão, espuma, filme
11. CN 1-5L/min, Máscara 5-10, Venturi, Reservatório
12. SNG(estômago), SNE(intestino), Vesical(bexiga), Retal(retro)
13. Sem febre, FC normal, FR normal, PA normal
14. Sem icterícia, corado, hidratado, consciente
15. Fowler 45°, Semi-Fowler 30°, Sims, Trendelenburg
16. <18,5 / 18,5-24,9 / 25-29,9 / ≥30
17. Crioterapia=frio, Termoterapia=calor
18. Mecânica, química, ambiental
19. Confirmar óbito → higiene → identificação → família
20. Admissão: ID+SV+histórico. Alta: resumo+orientações
21. Sangue/jejum, Urina/jato médio, Fezes/3 amostras
22. Wanda Horta baseada em Maslow
23. Objetividade, cronologia, clareza, sigilo
24. Deltoide(2mL), Vasto lateral(5mL), Glúteo(4mL)
25. Passos para calçar luvas estéreis
26. Limpa ≠ Estéril
27. Urinou, fezes normais, andando
28. Mudança de decúbito a cada 2h — prevenir LPP
29. Cuidados sonda vesical
30. Cuidados medicação por sonda
31. Estrutura SOAP (S-O-A-P)
32. Necessidades fisiológicas/biológicas
33. Sociais + Espirituais
34. Banho no leito: materiais e sequência
35. Indicações de contenção
36. Papel do enfermeiro no pós-morte
37. Balanço hídrico
38. Gotejamento: macro/microgotas
39. CV, FC, PA, FR, Tax, SatO₂
40. Passos do curativo simples
41. Cuidados oxigenoterapia
42. Precauções padrão
43. Ampola VS Frasco-ampola VS Soro
44. Medidas antropométricas
45. Complicações SNG/SNE
46. Histórico de enfermagem
47. Aplicações prática da teoria
48. Bradi/Taqui (+/-)
49. Cuidados medicação EV
50. LPP: estágios 1-4
51. EPIs e indicações
52. Verificação SNG
53. TOT, CVC, Penrose, Portovac
54. Contraindicações crioterapia
55. Regra de três
56. Diagnóstico de enfermagem NANDA-I
57. Passagem de plantão
58. Cama ocupada × desocupada
59. Erro de medicação: conduta
60. ★ TOP 5 80/20



Guia de Recorte

Cada flashcard tem ≈ 9 × 13 cm (dobre ao meio e cole se desejar um cartão mais firme)